

Thrombectomie cérébrale — prise en charge anesthésique

Méthodologie, 4 champs (18 préconisations) & sources



Champ : recommandations sur la prise en charge anesthésique et péri-interventionnelle lors d'une procédure de thrombectomie mécanique (TM) chez les patients victimes d'un AVC ischémique par occlusion artérielle cérébrale. Comité de 15 experts (SFAR, ANARLF, SFNV, SFNR) sous la supervision de 2 coordonnateurs. Processus mené indépendamment de tout financement industriel. 4 champs : (1) modalités de prise en charge per-interventionnelle (type d'anesthésie), (2) gestion des ACSOS (agressions cérébrales secondaires d'origine systémique), (3) gestion des antiagrégants plaquettaires et anticoagulants, (4) gestion post-interventionnelle et orientation.

Méthodologie : format **RPP** (Recommandations pour la Pratique Professionnelle) plutôt que RFE — choix motivé par la source elle-même (trop peu d'études de puissance suffisante sur le critère de jugement majeur, le pronostic neurologique à 3 mois/score de Rankin). La méthodologie GRADE® a néanmoins guidé l'analyse de la littérature (niveau de preuve par référence). 15 questions traitées sur les 4 champs ; 18 préconisations formalisées, **toutes accord fort après 2 tours de cotation** ; 2 questions n'ont donné lieu à **aucune recommandation** (littérature insuffisante), disclosure explicite reproduite telle quelle plutôt qu'omise.

Légende

AE

Les 18 préconisations de ce document portent toutes la même mention imprimée par la source : « **Avis d'experts (Accord fort)** » — format RPP, pas de distinction GRADE 1+/1-/2+/2- individuelle (voir disclosure méthodologique en page 1).

Champ 1 — Modalités de prise en charge per-interventionnelle

Question : l'anesthésie locale seule, comparativement à l'anesthésie générale (AG) ou à la sédation procédurale (SP), permet-elle d'améliorer le pronostic neurologique à 3 mois ?

Réf.	Recommandation	Accord
R1.1.1	Les experts suggèrent de privilégier l'AG avec intubation orotrachéale, réalisée par une équipe anesthésique, plutôt que l'anesthésie locale seule, lorsqu'au moins une des situations suivantes est présente : atteinte de la circulation postérieure ; neuronavigation radiologique prévue délicate ; NIHSS ≥ 15 ; altération de la vigilance ; défaillance respiratoire ; agitation du patient ; vomissements.	AE
R1.1.2	À l'exception des situations ci-dessus nécessitant une intubation, les experts suggèrent de ne pas privilégier l'AG par rapport à une anesthésie locale sous surveillance par une équipe d'anesthésie.	AE

Question : la sédation procédurale (SP), comparativement à l'AG, permet-elle d'améliorer le pronostic neurologique à 3 mois ?

Réf.	Recommandation	Accord
R1.2	À l'exception des situations nécessitant une intubation (cf. R1.1.1), les experts suggèrent de ne pas privilégier l'AG par rapport à une SP, l'une et l'autre réalisées par une équipe anesthésique.	AE

Champ 2 — Gestion des ACSOS

Question : une cible de pression artérielle (PA) en post-recanalisation est-elle associée à une amélioration du pronostic neurologique à 3 mois ?

Réf.	Recommandation	Accord
R2.1.1	En cas de recanalisation TICI $< 2b$, les experts suggèrent de maintenir une PA systolique post-procédure entre 130 et 180 mmHg.	AE
R2.1.2	En cas de recanalisation TICI $\geq 2b$, les experts suggèrent de maintenir une PA systolique post-procédure entre 130 et 160 mmHg.	AE
R2.2	Les experts suggèrent de maintenir la SpO ₂ du patient ≥ 95 % en per- et post-procédure.	AE
R2.3	Lors des procédures sous AG, les experts suggèrent de surveiller l'etCO ₂ et de le maintenir entre 35 et 40 mmHg.	AE

Thrombectomie cérébrale — prise en charge anesthésique

Méthodologie, 4 champs (18 préconisations) & sources



Réf.	Recommandation	Accord
R2.4	Lors des procédures sous sédation, les experts suggèrent de monitorer en continu l'etCO ₂ afin de surveiller la persistance de la ventilation spontanée.	AE
R2.5	Les experts suggèrent de monitorer et traiter les épisodes d'hyperglycémie, tout en évitant les hypoglycémies induites par ce contrôle.	AE

Champ 3 — Gestion des anticoagulants et antiagrégants plaquettaires

Disclosure : la source intitule ce champ de 3 façons légèrement différentes selon l'endroit du document (« Gestion des anticoagulants et antiagrégants plaquettaires » en en-tête de section, « Gestion des antiagrégants plaquettaires et des anticoagulants » dans le résumé des champs) — titre d'en-tête retenu ici, divergence non résolue par la source elle-même.

Réf.	Recommandation	Accord
R3.1	Chez les patients ayant bénéficié préalablement d'une thrombolyse intraveineuse, les experts suggèrent de ne pas procéder à une héparinisation systémique en per-procédure.	AE

Absence de recommandation — chez le patient sans thrombolyse intraveineuse préalable, l'héparinisation systémique per-procédure permet-elle d'améliorer le pronostic neurologique à 3 mois ?

À ce jour, la littérature disponible ne permet pas de se prononcer sur un éventuel intérêt de l'héparinisation systémique chez ces patients.

Réf.	Recommandation	Accord
R3.2	En l'absence de thrombolyse intraveineuse préalable, les experts suggèrent de ne pas administrer systématiquement à tous les patients une antiagrégation plaquettaire par anti-GPIIb/IIIa ou inhibiteur direct de la thrombine ; ce traitement peut être proposé en cas d'embolies distales pendant la procédure ou d'occlusion persistante en fin de procédure.	AE
R3.3	Les experts suggèrent de ne pas administrer d'aspirine en per-procédure, que les patients aient bénéficié ou non d'une thrombolyse intraveineuse préalable, afin de ne pas augmenter le risque d'hémorragie intra-parenchymateuse symptomatique.	AE
R3.4.1	Les experts suggèrent d'utiliser une antiagrégation plaquettaire (simple ou double) lors de la pose d'un stent pour éviter sa thrombose.	AE
R3.4.2	Les experts suggèrent de n'initier cette antiagrégation qu'après avoir éliminé une hémorragie cérébrale par imagerie de contrôle au cours des premières 24 heures suivant le geste.	AE

Champ 4 — Prise en charge post-interventionnelle et orientation

Disclosure : la source intitule ce champ « Prise en charge post-interventionnelle immédiate et orientation » en en-tête de section, et « Gestion post-interventionnelle et orientation » dans le résumé des champs — divergence non résolue par la source elle-même.

Réf.	Recommandation	Accord
R4.1.1	Les experts suggèrent d'arrêter les médicaments d'anesthésie dès la fin de la procédure de TM en l'absence de défaillance ventilatoire ou de complications faisant craindre une HTIC ou un état de mal épileptique.	AE
R4.1.2	Les experts suggèrent d'extuber le patient immédiatement après la procédure si les prérequis habituels sont présents et l'état de vigilance satisfaisant (composante visuelle du score de Glasgow ≥ 3 ; la réponse aux ordres n'est pas nécessaire). Déglutition et toux à évaluer spécifiquement pour les occlusions de la circulation postérieure.	AE

Absence de recommandation — chez le patient ayant bénéficié d'une thrombectomie cérébrale sous anesthésie générale, une stratégie d'extubation précoce guidée par des échelles (score VISAGE, etc.) permet-elle d'améliorer la morbi-mortalité ?

À ce jour, la littérature disponible ne permet pas de se prononcer sur un éventuel intérêt de l'utilisation d'échelles ou de scores pour guider l'extubation précoce dans cette population.

Thrombectomie cérébrale — prise en charge anesthésique

Méthodologie, 4 champs (18 préconisations) & sources



Réf.	Recommandation	Accord
R4.2	Les experts suggèrent que le patient soit admis en unité de soins critiques, en priorité en USINV, avec surveillance clinique (glycémie, température) et monitoring (PA, SpO2, ECG), au minimum jusqu'à l'imagerie cérébrale de contrôle à H24.	AE
R4.3	Les experts suggèrent de ne pas ré-adresser le patient immédiatement après la procédure vers le centre adresseur en cas d'instabilité hémodynamique, de déficit neurologique sévère (NIHSS ≥ 15), ou de résultat incomplet au contrôle de la procédure (TICI $< 2b$).	AE

Sources et traçabilité

Déclaration d'intérêts : une politique officielle de gestion des conflits d'intérêts a été élaborée dès le début du processus et appliquée tout au long de celui-ci ; l'ensemble du processus a été mené indépendamment de tout financement industriel.

Document source : « Prise en charge anesthésique péri-procédurale d'une revascularisation cérébrale par thrombectomie » — RPP, SFAR en association avec l'ANARLF, avec la participation de la SFNR, de la SFNV et du GFHT. Texte validé par le Comité des Référentiels Cliniques de la SFAR (16/05/2022), le CA de la SFAR (29/06/2022), le bureau de l'ANARLF (29/06/2022), le CS/CA de la SFNV (07/10/2022) et le CS de la SFNR (16/08/2022). Auteurs : H. Quintard, V. Degos, M. Mazighi, J. Berge, P. Boussemart, R. Chabanne, S. Figueiredo, T. Geeraerts, Y. Launey, L. Meuret, J.-M. Olivot, J. Pottecher, F. Rapido, S. Richard, V. Siguret-Depasse, O. Naggara, H. De Courson, M. Garnier.

Version : 2022.

Méthodologie : format RPP, analyse de la littérature selon GRADE®, cotation collective GRADE Grid — voir détail en page 1.

URL source : <https://sfar.org/download/prise-en-charge-anesthesique-peri-procedurale-dune-revascularisation-cerebrale-par-thrombectomie/?wpdmdl=37892>

Couverture : intégralité des 4 champs, des 18 préconisations (texte complet + grade) et des 2 questions sans recommandation. La bibliographie du document source est répartie en 16 listes de références numérotées localement par question (non consolidées en une liste unique) et détaille l'argumentaire de chaque préconisation — cette fiche condense l'argumentaire à ses éléments réellement actionnables et exclut explicitement ces listes de références : se référer au texte intégral pour le détail des études.

Avertissement — document de 2022 : ce document est une fiche de synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Elle reprend l'intégralité des 18 préconisations et des 2 disclosures d'absence de recommandation, mais ne remplace pas le texte intégral (argumentaire complet, références bibliographiques) et n'est ni éditée ni validée par la SFAR, l'ANARLF, la SFNR, la SFNV ou le GFHT. En cas de doute, se référer au texte intégral et/ou à un avis spécialisé.